

一、疾病理解與病理機轉

肺炎是肺部受到細菌、病毒等病原體感染而發炎的疾病,會讓肺部實質組織充滿發炎物質,影響氧氣交換功能。急性呼吸衰竭則是肺部無法順利吸入氧氣或排出二氧化碳,導致血液中氧氣太低或二氧化碳太高,這可能是因為腦部、肺部或呼吸肌肉出了問題,嚴重時會影響全身器官功能。

二、藥物知識與服藥遵從

1. 肺炎治療需按時服用醫師開立的抗生素,完整療程約7~14天,不可自行停藥。
2. 呼吸衰竭可能需要使用支氣管擴張劑、類固醇等藥物來幫助呼吸順暢。
3. 若有糖尿病,需定期監測血糖並按醫囑使用胰島素或口服藥。
4. 焦慮症患者需規律服用抗憂鬱劑或鎮定劑,不可自行調整劑量。
5. 癲癇患者必須每天定時服用抗癲癇藥物,擅自停藥可能誘發發作。
6. 高血脂藥物需長期規律服用,才能有效控制膽固醇水平。

三、警訊辨識與處置行為

1. 呼吸變得急促、喘不過氣或嘴唇發紫時要立即就醫。
2. 痰液變得濃稠、顏色變黃或咳不出來時需緊急返院。
3. 持續發燒超過38.5°C且不退燒時應尋求醫療協助。
4. 意識變得混亂、嗜睡或叫不醒時是危險警訊。
5. 癲癇發作超過30分鐘或反覆發作且意識未恢復需急診。
6. 突然無法吃喝、體力急遽下降時要趕快就醫。

四、飲食與活動建議

1. 採用高蛋白、高熱量、高維生素飲食來增加身體抵抗力。
2. 每天飲水3000~4000毫升(無限水情況下)幫助稀釋痰液。
3. 避免吸菸、喝酒和刺激性食物如咖啡、油炸物。
4. 均衡飲食,多攝取深綠色蔬菜、豆製品和堅果類食物。
5. 一週至少運動3次,每次30分鐘以上,選擇適合自己的方式。
6. 保持充足睡眠,避免過度勞累和劇烈運動如潛水、攀岩。

五、出院追蹤與門診照護導引

1. 出院後需按醫囑定期回門診追蹤胸部X光和血液檢查。
2. 糖尿病患者要記錄血糖值,回診時提供醫師調整藥物參考。
3. 癲癇患者需定期回神經科門診追蹤腦波和藥物調整。
4. 高血脂患者要定期抽血檢查膽固醇數值。
5. 焦慮症患者應持續接受心理治療和藥物治療。
6. 有緊急狀況可撥打諮詢電話(02)2737-2181相關分機尋求協助。

六、慢性疾病追蹤與照護提醒

【個人化慢性疾病追蹤與照護提醒】

以下慢性病是依診斷 ICD-10 自動辨識,請配合醫師門診追蹤與用藥調整。

■ 第一型糖尿病(ICD-10: E1010)

- 目前用藥中可能包含降血糖藥或胰島素,請規律監測血糖,並留意冒冷汗、手抖、心悸等低血糖症狀。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 胰島素幫浦或注射須按時執行,不可自行調整劑量;定期監測血糖,注意低血糖症狀(手抖、冒汗、頭暈)。
- 隨身攜帶葡萄糖凝膠或糖果,以備低血糖緊急處理。
- 詳細記錄血糖值與胰島素劑量,回診時提供醫師參考。

■ 癲癇(ICD-10: G40909)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 規律服用抗癲癇藥物,不可擅自停藥或減量;不喝酒、不熬夜、維持規律作息。
- 避免從事高風險活動(游泳、攀岩、駕車);確保居家環境安全(避免尖銳物品)。
- 癲癇發作超過30分鐘或兩次發作間意識未恢復,需緊急就醫。

■ 甲狀腺功能低下(ICD-10: E039)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 每日固定時間空腹服用甲狀腺素(Levothyroxine),服藥前後1小時避免喝牛奶或服用鈣片。
- 不可自行調整劑量;定期抽血監測 TSH,通常每6個月追蹤一次。

■ 高血脂症(ICD-10: E7800)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 減少高膽固醇及飽和脂肪攝取,選擇清蒸、水煮等低油烹調方式,增加膳食纖維。
- 規律運動(每週至少3次,每次30分鐘以上),維持理想體重。
- 按時服用降血脂藥物,不可自行增減劑量或停藥;定期抽血追蹤膽固醇數值。

■ 焦慮症(ICD-10: F419)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 按醫囑規律服用抗焦慮藥物;配合認知行為治療或放鬆訓練(腹式呼吸、正念)。
- 避免咖啡因和酒精,維持規律睡眠與作息;焦慮影響日常功能時應回診評估。

七、參考衛教手冊

1. 肺炎
2. 急性呼吸衰竭
3. 血糖自我監測衛教指導

4. 焦慮症
5. 癲癇(成人)
6. 高血脂症護理指導

※ 此衛教手冊由人工智慧輔助生成，僅供參考，不代替醫師專業建議。

生成日期：2026-05-31